PROCÈS-VERBAL OFFICIEL

Réunion de Cadrage, de Collecte d'Informations et d'Analyse des Besoins

MISSION : DIGITALISATION DE LA GESTION DES STOCKS, DES ACHATS ET DE LA PHARMACIE

Clinique BAGUIDI « L'As du Cœur » | Quartier Zongo II, Parakou
Date : 13 juillet 2026

PAGE D'IDENTIFICATION

Projet	Mise en place d'outil de gestion de stock de la CLINIQUE BAGUIDI « *L'AS DU CŒUR* »
Mission	Rapport de Cadrage, de Collecte d'Informations et d'Analyse des Besoins, Gestion des Stocks, des Achats, de la Pharmacie, du Laboratoire et des Ressources Humaines
Structure bénéficiaire	Clinique BAGUIDI « L'As du Cœur »
Structure d'accompagnement	FAGUEZ SARL
Date	13 juillet 2026
Lieu	Clinique BAGUIDI « L'As du Cœur » – Quartier Zongo II, Parakou
Horaire	Séance de travail – Journée du 13 juillet 2026
Consultants / Prestataires	Dr MASSENON Rhodes (Chef de mission) Ing. KOWI Alfred (Consultant Systèmes d'Information)
Responsables rencontrés	Dr BAGUIDI Rafiou — Directeur Général, Médecin du Travail SANOUSSI Adamon — Comptable MABOUDOU Nawal — Comptable IDOHOU Abraham — Responsable des Ressources Humaines

SOMMAIRE

Remerciements 3
Résumé exécutif 4
1. Contexte de la mission 5
3.1. Entretiens directifs et atelier de cadrage 6
3.2. Analyse documentaire 6
3.3. Restitution et validation 6
4.1. Représentants de la Clinique BAGUIDI 6
4.2. Équipe Consultant 6
5. Déroulement de la réunion de cadrage 7
7.1. Outils et supports utilisés 7
7.2. Organisation du stock 8
7.3. Nature des produits gérés 8
7.4. Cycle de vie du stock observé 8
7.5. Approvisionnement et fournisseurs 9
7.6. Gestion des entrées 9
7.7. Gestion des sorties 9
7.8. Gestion des retours 9
7.9. Gestion des péremptions 9
7.10. Inventaire 9
8.1. Processus Achats – AS-IS 10
8.2. Processus Pharmacie Gros → Pharmacie Détail – AS-IS 10
8.3. Processus de facturation et dispensation – AS-IS 10
8.4. Processus Laboratoire – AS-IS 10
8.5. Processus de retour Caisse – Patient – Pharmacie – AS-IS 10
8.6. Processus Patients Assurés – AS-IS 10
8.7. Processus Inventaire quotidien – AS-IS 10
9.1. Gestion des achats et des fournisseurs 11
9.2. Gestion des stocks – Pharmacie de gros et de détail 11
9.3. Gestion du laboratoire et des réactifs 11
9.4. Gestion des fournitures administratives et consommables 11
9.5. Gestion des bons de commande et de livraison 11
9.6. Gestion des factures fournisseurs et de la fiscalité (AIB) 12
9.7. Gestion des inventaires 12
9.8. Intégration avec le logiciel de caisse et le logiciel d'assurance 12
9.9. Gestion des ressources humaines et de la paie 12
9.10. Tableaux de bord et rapports 13
10. Besoins non fonctionnels 13
11. Contraintes organisationnelles 13
Annexe 16
Liste des documents collectés et analysés 16

Remerciements

Les Consultants Massenon & Kowi Conseil tient à remercier la Direction Générale de la Clinique BAGUIDI « L'As du Cœur » pour la confiance accordée dans le cadre de cette mission de cadrage, ainsi que pour la disponibilité et la qualité des échanges qui ont permis de conduire cette première phase d'analyse dans des conditions optimales.

Nos remerciements s'adressent tout particulièrement au Docteur BAGUIDI Rafiou, Médecin du Travail et Directeur Général, ainsi qu'à l'ensemble des collaborateurs qui ont pris part à la réunion de cadrage du 13 juillet 2026 : Monsieur SANOUSSI Adamon et Madame MABOUDOU Nawal, Comptables, et Monsieur IDOHOU Abraham, Responsable des Ressources Humaines. Leur connaissance fine du fonctionnement quotidien de la clinique, leur transparence sur les difficultés rencontrées et leur implication active ont constitué un facteur déterminant de la qualité des informations recueillies.

Nous remercions également l'ensemble du personnel administratif, comptable et soignant qui, par la mise à disposition de documents de travail (journaux comptables, cahiers de stock, bons de livraison, fiches de garde, annexes fiscales), a permis à l'équipe de mission de fonder son diagnostic sur des éléments concrets et représentatifs de la réalité opérationnelle de l'établissement.

Résumé

La Clinique BAGUIDI « L'As du Cœur », établissement de santé privé installé à Parakou depuis 2008, a sollicité le cabinet Massenon & Kowi Conseil afin de l'accompagner dans la digitalisation de la gestion de ses stocks, de ses achats et de sa pharmacie. Cette démarche s'inscrit dans une volonté plus large de modernisation du système d'information de l'établissement, dont la première phase, objet du présent rapport, couvre les achats, les fournisseurs, la pharmacie de gros et de détail, le laboratoire, les réactifs, les fournitures administratives, la gestion des stocks, les inventaires, les ressources humaines et la paie, ainsi que l'intégration avec le logiciel de caisse et le dispositif de gestion des assurés déjà en place.

La séance de cadrage tenue le 13 juillet 2026 dans les locaux de la clinique a permis de dresser un état des lieux précis du fonctionnement actuel. Il en ressort une organisation rigoureuse mais entièrement manuelle et fragmentée : suivi comptable sous Excel (achats, ventes, salaires, opérations diverses, immobilisations, AIB), tenue de cahiers de stock et de sortie au niveau de la pharmacie et du laboratoire, absence d'étiquetage et de code de traçabilité des produits, et coexistence de deux outils informatiques cloisonnés, un logiciel de caisse et un logiciel de gestion des assurances, qui ne communiquent aujourd'hui avec aucun système de gestion de stock.

Cette organisation, bien que maîtrisée par des équipes expérimentées, expose la clinique à des risques opérationnels significatifs : absence de traçabilité automatisée des entrées et sorties, difficultés de réalisation des inventaires, absence d'alerte automatique sur les seuils de stock et les dates de péremption, ressaisies multiples entre les différents journaux Excel, et absence de vision consolidée et en temps réel de la situation des stocks et de la trésorerie liée aux achats.

Sur la base de ce diagnostic, le cabinet recommande la mise en place d'un outil de gestion intégré, modulaire et évolutif, structuré autour de la gestion des achats et des fournisseurs, de la gestion des stocks (pharmacie de gros et de détail, laboratoire, réactifs, fournitures), de la gestion des inventaires et des alertes, et de la gestion des ressources humaines et de la paie, le tout interfacé avec le logiciel de caisse existant et le dispositif de gestion des assurés. Cette première phase constitue le socle sur lequel pourront s'appuyer, à moyen terme, des évolutions complémentaires du système d'information de la clinique, qui ne sont pas traitées dans le présent périmètre de mission.

Le présent rapport constitue le socle documentaire à partir duquel sera élaboré le Cahier des Charges Fonctionnel et Technique du futur outil, document distinct remis conjointement au présent rapport.

1. Contexte de la mission

La Clinique BAGUIDI « L'As du Cœur » est un établissement de santé privé créé en 2008, spécialisé notamment en médecine du travail et médecine générale, situé à Parakou. L'établissement fonctionne avec une organisation administrative comprenant une Direction Générale, un service comptable, un service des ressources humaines, et des unités opérationnelles (pharmacie de gros, pharmacie de détail, laboratoire, consultations, soins).

À ce jour, l'ensemble des processus de gestion des stocks, des achats et de la pharmacie repose sur des outils bureautiques (Microsoft Excel) et des supports papier (cahiers de stock, cahiers de sortie, fiches de garde). Seuls deux domaines bénéficient d'une informatisation partielle : la caisse, équipée d'un logiciel dédié à la facturation des consultations et des prestations, et la gestion des assurances, à travers un outil permettant de vérifier la validité des cartes d'assurés auprès des compagnies partenaires (NSIA, ASCOMA, OLEA, SUNU, Gras Savoye, entre autres).

Face à la croissance de l'activité et à la multiplication des points de contrôle manuels, la Direction Générale a souhaité engager une démarche de digitalisation progressive de son système d'information, en commençant par les processus les plus sensibles en termes de risques financiers et opérationnels : les achats, les stocks et la pharmacie. C'est dans ce cadre que le cabinet Massenon & Kowi Conseil a été mandaté pour conduire une mission de cadrage et d'analyse des besoins, préalable indispensable à la rédaction du cahier des charges fonctionnel et technique de la future solution.

2. Objectifs de la mission

La mission de cadrage poursuit quatre objectifs principaux :

1. Dresser un diagnostic précis et objectif de l'organisation actuelle de la gestion des achats, des stocks et de la pharmacie de la Clinique BAGUIDI (analyse de l'existant – AS-IS).
2. Recueillir de manière exhaustive les besoins fonctionnels et non fonctionnels exprimés par les responsables opérationnels et la Direction Générale.
3. Identifier les risques, les contraintes et les opportunités d'amélioration liés au fonctionnement actuel, et formuler des recommandations stratégiques.
4. Poser les bases documentaires nécessaires à la rédaction du Cahier des Charges Fonctionnel et Technique qui guidera le développement ou le paramétrage de la future solution logicielle.

Conformément au périmètre validé avec la Direction Générale, la présente mission de cadrage se concentre exclusivement sur les domaines suivants : gestion des achats et des fournisseurs, gestion des stocks (pharmacie de gros et de détail, laboratoire, réactifs, fournitures administratives et consommables), gestion des bons de commande et de livraison, gestion des factures fournisseurs, gestion des fiches de stock et de sortie, gestion des seuils d'alerte et des dates de péremption, gestion des inventaires, intégration avec le logiciel de caisse existant, gestion des assurances dans le cadre de cette intégration, gestion des ressources humaines et de la paie, ainsi que les tableaux de bord et rapports de gestion associés. Les évolutions futures évoquées lors des échanges (dossier patient informatisé, module de consultation et d'hospitalisation, portail patient, application mobile, business intelligence avancée) sont hors périmètre du présent rapport et feront l'objet de phases ultérieures distinctes.

3. Méthodologie de collecte des besoins

L'équipe de mission a mobilisé une méthodologie éprouvée de conseil en transformation digitale, structurée en trois étapes complémentaires :

3.1. Entretiens directifs et atelier de cadrage

Une réunion de cadrage a été organisée le 13 juillet 2026 dans les locaux de la clinique, réunissant la Direction Générale, le service comptable et le service des ressources humaines. Cette réunion a suivi une trame structurée en neuf thématiques : objectifs stratégiques, organisation actuelle, nature des produits gérés, cycle de vie du stock, approvisionnement, gestion des entrées, gestion des sorties, gestion des péremptions et inventaire.

3.2. Analyse documentaire

L'équipe de mission a examiné un échantillon représentatif des documents de gestion actuellement utilisés par la clinique, notamment : le classeur Excel « Journal de Janvier 2026 » (onglets Achats, Ventes, Salaires, Caisse-Dépenses, Opérations Diverses, Prestations, Point AIB et Immobilisations), des bons de livraison émis par la Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS), une fiche de suivi des gardes et permanences médicales, ainsi que des notes manuscrites de cadrage rédigées en séance par les consultants.

3.3. Restitution et validation

Les constats et besoins recueillis ont fait l'objet d'une synthèse structurée, restituée dans le présent rapport, qui sera soumise à la validation formelle de la Direction Générale avant l'engagement de la phase de rédaction du Cahier des Charges Fonctionnel et Technique et l'implémentation.

4. Participants

4.1. Représentants de la Clinique BAGUIDI

Nom et prénom	Fonction	Rôle dans la mission
Dr BAGUIDI Rafiou	Directeur Général – Médecin du Travail	Validation des expression des besoins et attentes
SANOUSSI Adamon	Comptable	Expression des besoins comptables et achats, stock
MABOUDOU Nawal	Comptable	Expression des besoins comptables et ventes
IDOHOU Abraham	Responsable des Ressources Humaines	Expression des besoins RH et paie

4.2. Équipe Consultant

Nom et prénom	Fonction	Rôle dans la mission
Dr MASSENON Rhodes	Chef de mission	Pilotage de la mission, analyse organisationnelle
Ing. KOWI Alfred	Consultant Systèmes d'Information	Analyse fonctionnelle et technique

5. Déroulement de la réunion de cadrage

La réunion de cadrage s'est tenue le 13 juillet 2026 dans les locaux de la Clinique BAGUIDI, autour du projet intitulé « Mise en place d'un outil de gestion de stock ». Elle avait pour objectif d'obtenir une vision claire des besoins, des contraintes et des attentes de l'établissement, ainsi que de comprendre le fonctionnement réel de la clinique.

Les échanges ont été organisés autour des séquences suivantes :

- Introduction et rappel des objectifs de la mission par le chef de mission ;
- Présentation par la Direction Générale des motivations du projet et des attentes en matière de digitalisation ;
- Description détaillée, par le service comptable, de l'organisation actuelle des achats, des stocks et de la pharmacie ;
- Description par le service RH du processus de gestion des gardes, des permanences et de la paie ;
- Recensement des pertes et dysfonctionnements constatés (ruptures de stock, produits périmés, surstock, vol, traçabilité, difficultés d'inventaire) ;
- Échange sur les attentes vis-à-vis du futur outil et sur les contraintes d'intégration avec les logiciels existants (caisse et assurances) ;
- Définition des prochaines étapes de la mission.

Cette réunion a été complétée par la mise à disposition, par les équipes de la clinique, d'un ensemble de documents de travail permettant de vérifier et d'illustrer concrètement les propos recueillis en séance.

6. Présentation de la Clinique BAGUIDI

Créée en 2008, la Clinique BAGUIDI « L'As du Cœur » est un centre de médecine du travail et de médecine générale basé à Parakou, au quartier Zongo II. L'établissement propose des consultations généralistes, des prestations de soins, des analyses de laboratoire et la dispensation de médicaments et de produits de santé à travers ses deux pharmacies internes.

L'organisation administrative et fonctionnelle de la clinique repose sur quatre pôles principaux :

- La Direction Générale, assurée par le Docteur BAGUIDI Rafiou;
- Le service comptable, en charge du contrôle des recettes et des dépenses, de la gestion des stocks et des achats, des états financiers et du recouvrement ;
- Le service des ressources humaines, en charge de la gestion administrative du personnel et de la paie, y compris la rémunération des médecins par garde et permanence ;
- Les unités opérationnelles de soins : consultation généraliste, laboratoire, pharmacie de gros et pharmacie de détail.

7. Analyse de l'existant (AS-IS)

7.1. Outils et supports utilisés

La gestion administrative, comptable et logistique de la clinique repose aujourd'hui sur une combinaison d'outils bureautiques et de supports papier, sans intégration entre eux :

Outil / support	Usage actuel	Niveau d'informatisation
Microsoft Excel	Journaux Achats (ACH), Ventes (VEN), Salaires (SAL), Caisse-Dépenses, Opérations Diverses (OD), Prestations (PRE), Point AIB, Immobilisations (IMO)	Bureautique – saisie manuelle
Cahiers de stock	Suivi des entrées et sorties de produits en pharmacie et au laboratoire	Manuel – papier
Cahiers de sortie	Enregistrement des sorties de produits par patient, date et désignation	Manuel – papier
Logiciel de caisse	Facturation des consultations, encaissement, édition de tickets patient / infirmier	Informatisé – non interfacé
Logiciel de gestion des assurances	Vérification de la validité des cartes d'assurés, facturation des compagnies partenaires	Informatisé – non interfacé
Fiches de garde, paie manuscrites	Suivi des heures de garde et de permanence des médecins pour le calcul de la rémunération	Manuel – papier

7.2. Organisation du stock

La clinique dispose de deux pharmacies internes — une pharmacie de gros, qui réceptionne et stocke les produits commandés auprès des fournisseurs, et une pharmacie de détail, alimentée par petites quantités depuis la pharmacie de gros pour la dispensation directe aux patients. Aucun dépôt secondaire n'existe en dehors de ces deux structures. Le laboratoire gère, de son côté, un stock distinct de réactifs, suivi également par cahier.

7.3. Nature des produits gérés

Les produits gérés par la clinique, hors vaccins qui ne sont pas concernés par le périmètre actuel, se répartissent en cinq grandes catégories :

- Les médicaments et solutions injectables (antibiotiques, antalgiques, solutés de perfusion, etc.) ;
- Les consommables médicaux (compresses, coton hydrophile, sparadrap, seringues) ;
- Les produits de laboratoire et réactifs ;
- Le petit matériel médical ;
- Les fournitures administratives, produits d'entretien et charges connexes (papeterie, eau, gasoil, électricité).

7.4. Cycle de vie du stock observé

Le cycle de vie du stock, tel qu'observé et décrit par les équipes de la clinique, suit la séquence suivante :

5. Émission d'un bon de commande, saisi manuellement par le service comptable ;
6. Approbation du bon de commande par le Directeur Général ;
7. Transmission du bon de commande au fournisseur retenu ;
8. Livraison et émission, par le fournisseur, d'un bon de livraison et d'une facture normalisée (exemple observé : bon de livraison SoBAPS n° 26BLP0704 du 17 juin 2026) ;

9. Réception, contrôle des quantités et des dates de péremption par le service comptable, puis stockage en pharmacie de gros ;
10. Distribution vers la pharmacie de détail ou les autres services sur demande formalisée par un support de suivi signé par le demandeur.

Il ressort de cette description qu'aucun contrôle qualité formalisé n'est réalisé à la réception, que les produits ne sont ni photographiés ni étiquetés, et qu'aucune procédure de destruction n'est nécessaire à ce jour, les commandes étant passées sur une base mensuelle afin de limiter le risque de péremption. Il n'existe par ailleurs pas de procédure de retour entre la clinique et ses fournisseurs.

7.5. Approvisionnement et fournisseurs

Les commandes sont émises par le service comptable auprès d'une liste de fournisseurs agréés, parmi lesquels la Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS), la Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels (CAME), ainsi que plusieurs pharmacies de la place pour les commandes urgentes ou complémentaires. Chaque fournisseur dispose de son propre numéro d'enregistrement client auprès de la clinique et établit systématiquement un bon de livraison et une facture normalisée. Le délai moyen de livraison n'est pas formellement mesuré à ce jour, ce qui constitue un axe d'amélioration identifié par le cabinet.

7.6. Gestion des entrées

À la réception d'une livraison, le service comptable vérifie les quantités livrées par rapport au bon de commande, ainsi que les dates de péremption des produits reçus. Les numéros de lot figurent sur les bons de livraison des fournisseurs (à titre d'exemple, le bon de livraison SoBAPS n° 26BLP0704 mentionne systématiquement les numéros de lot et les dates d'expiration pour chaque référence livrée), mais ces informations ne sont pas ressaisies dans un système centralisé de suivi de stock.

7.7. Gestion des sorties

Les sorties de stock concernent la pharmacie de détail, le bloc, le laboratoire, la consultation et l'hospitalisation. Elles sont, selon les informations recueillies, nominatives, tracées par patient et par service, mais uniquement sur support papier (cahier de sortie), ce qui limite les possibilités d'analyse consolidée et de rapprochement avec la facturation émise par la caisse.

7.8. Gestion des retours

Il n'existe pas de circuit de retour entre la clinique et ses fournisseurs. En revanche, un circuit de retour existe entre la caisse, le patient et la pharmacie de détail : lorsque le produit délivré ne correspond pas à celui facturé ou prescrit, celui-ci est retourné et une observation est consignée, avec correction du produit facturé.

7.9. Gestion des péremptions

Aucun dispositif de suivi automatisé des dates de péremption n'est actuellement en place. La clinique limite le risque de péremption par une politique d'achat mensuel, adaptée aux besoins constatés, complétée par des commandes d'urgence auprès des pharmacies de la place en cas de besoin ponctuel. Cette pratique, efficace à ce jour, ne constitue toutefois pas une garantie pérenne face à la croissance du volume d'activité, d'où le besoin exprimé d'alertes automatiques.

7.10. Inventaire

Un inventaire est réalisé quotidiennement, chaque matin, par le service comptable et la caisse. Il consiste à recenser les recettes et dépenses de la journée précédente, à cumuler les dépenses validées par la caissière, et à rapprocher les différents modes de paiement (espèces, banque, chèques, Mobile Money via des passerelles telles que KKiaPay). Des écarts sont régulièrement constatés, liés au caractère entièrement manuel de ce processus.

8. Cartographie des processus métiers

Les processus clés identifiés lors de la mission de cadrage sont présentés ci-après sous forme de chaînes d'activités séquentielles (cartographie textuelle équivalente à une notation BPMN simplifiée), qui serviront de base à la modélisation détaillée des processus cibles (TO-BE) dans le Cahier des Charges Fonctionnel.

8.1. Processus Achats – AS-IS

Service Comptable → Rédaction du bon de commande → Directeur Général → Approbation → Envoi au fournisseur → Fournisseur → Livraison + Bon de livraison + Facture normalisée → Service Comptable → Contrôle quantités / péremptions → Entreposage Pharmacie Gros → Enregistrement dans le journal Excel Achats.

8.2. Processus Pharmacie Gros → Pharmacie Détail – AS-IS

Pharmacie Gros → Demande de réapprovisionnement de la Pharmacie Détail → Prélèvement d'un petit stock → Transfert vers la Pharmacie Détail → Enregistrement manuel (cahier de stock).

8.3. Processus de facturation et dispensation – AS-IS

Médecin → Prescription sur ordonnance → Patient → Présentation de l'ordonnance à la Caisse → Caisse → Facturation et émission de deux tickets (un ticket Infirmier, un ticket Patient, mentionnant les identifiants du patient, les analyses et les produits/médicaments prescrits) → Infirmier → Présentation du ticket à la Pharmacie Détail → Pharmacie Détail → Délivrance des produits → Patient → Règlement à la Caisse.

8.4. Processus Laboratoire – AS-IS

Prescription d'analyses → Ticket Patient référé par la Caisse → Laboratoire → Réalisation des analyses → Consommation de réactifs → Enregistrement manuel sur cahier de stock et de sortie du laboratoire.

8.5. Processus de retour Caisse – Patient – Pharmacie – AS-IS

Constat d'une non-conformité produit → Retour du produit par le Patient → Caisse → Consignation d'une observation → Pharmacie Détail → Correction du produit facturé et régularisation du stock.

8.6. Processus Patients Assurés – AS-IS

Patient assuré → Présentation de la carte d'assurance → Caisse → Vérification du numéro d'identifiant et de la validité de la carte → Détermination du taux de prise en charge (exemple observé : 20% à la charge du patient, 80% à la charge de l'assureur) → Facturation partagée → Facture normalisée détaillée transmise mensuellement à l'assureur pour règlement de sa quote-part.

8.7. Processus Inventaire quotidien – AS-IS

Ouverture de journée → Comptable et Caisse → Relevé des recettes et dépenses de la veille → Cumul des dépenses validé et signé par la caissière → Rapprochement multi-canal (espèces, banque, Mobile Money) → Report dans les journaux Excel correspondants.

9. Analyse détaillée des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels ci-après ont été recueillis lors de la réunion de cadrage et confirmés par l'analyse documentaire. Ils sont présentés par domaine et constitueront la base des exigences fonctionnelles détaillées du Cahier des Charges.

9.1. Gestion des achats et des fournisseurs

- Création et gestion d'une base de fournisseurs agréés (identité, code client, code fournisseur, coordonnées, numéro d'enregistrement) ;
- Saisie manuelle des bons de commande avec workflow d'approbation par la Direction Générale avant transmission au fournisseur ;
- Édition et impression des bons de commande (nom de l'établissement, code, téléphone, désignation, quantité demandée, quantité livrée, prix unitaire, montant) ;
- Rapprochement automatique entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture normalisée reçue du fournisseur ;
- Génération d'une facture proforma à la demande.

9.2. Gestion des stocks – Pharmacie de gros et de détail

- Tenue d'une fiche de stock par produit, mentionnant l'entête de l'établissement, la date, le nom du produit, le dosage, la forme (injectable ou comprimé), la date de péremption, le seuil d'alerte, et un tableau récapitulatif des entrées, sorties et stock disponible ;
- Tenue d'une fiche de sortie par mouvement, avec identification du produit, de la date et du bénéficiaire ;
- Distinction claire entre stock de la pharmacie de gros et stock de la pharmacie de détail, avec traçabilité des transferts entre les deux ;
- Gestion des seuils de stock minimum et alertes automatiques en cas de rupture imminente ;
- Gestion et notification automatique des dates de péremption approchantes ;
- Gestion du circuit de retour entre la caisse, le patient et la pharmacie, avec consignation d'observations et régularisation automatique du stock.

9.3. Gestion du laboratoire et des réactifs

- Suivi des stocks de réactifs selon la même logique que la pharmacie (fiche de stock, entrées, sorties, seuils, péremptions) ;
- Digitalisation du cahier de stock et de sortie actuellement tenu au niveau du laboratoire ;
- Rattachement des consommations de réactifs aux analyses prescrites et facturées.

9.4. Gestion des fournitures administratives et consommables

- Suivi distinct des fournitures administratives, des produits d'entretien et des charges connexes (eau, gasoil, électricité, papeterie) ;
- Circuit de demande interne et de validation avant sortie de stock, avec suivi du demandeur.

9.5. Gestion des bons de commande et de livraison

- Saisie manuelle des bons de commande avec approbation obligatoire du Directeur Général avant envoi ;
- Enregistrement des bons de livraison reçus, avec numéro, date, références produits, quantités, prix unitaires SoBAPS, montants hors taxes, AIB et net à payer, sur le modèle des documents fournisseurs observés.

9.6. Gestion des factures fournisseurs et de la fiscalité (AIB)

- Enregistrement des factures fournisseurs et calcul automatique de l'Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB), aux taux observés de 3% et 5% selon la nature du fournisseur et sa situation fiscale ;
- Édition d'une annexe mensuelle récapitulant, pour chaque fournisseur ou prestataire, le numéro IFU, l'adresse, le montant, le taux et le montant d'AIB correspondant, sur le modèle de l'annexe AIB actuellement produite sous Excel ;
- Gestion des opérations diverses liées aux surplus d'AIB constatés par fournisseur.

9.7. Gestion des inventaires

- Automatisation de l'inventaire quotidien (recettes, dépenses, stock, paiements) avec validation par la caissière ;
- Consolidation automatique du cumul des recettes et du niveau des dépenses, avec comparaison à un panier normalisé de référence ;
- Réduction des écarts constatés aujourd'hui du fait de la saisie manuelle.

9.8. Intégration avec le logiciel de caisse et le logiciel d'assurance

- Interfaçage entre le futur outil de gestion de stock et le logiciel de caisse existant, afin que la sortie de produit constatée en pharmacie soit rapprochée automatiquement de la facturation émise à la caisse ;
- Prise en compte du circuit à deux tickets (ticket Infirmier, ticket Patient) généré par la caisse lors de la facturation d'une ordonnance ;
- Interfaçage avec le dispositif de gestion des assurances pour la vérification des cartes, la répartition du taux de prise en charge patient/assureur, et l'édition mensuelle de la facture normalisée destinée à chaque compagnie d'assurance partenaire.

9.9. Gestion des ressources humaines et de la paie

- Gestion des salaires fixes du personnel permanent de la clinique ;
- Gestion de la rémunération des médecins par garde et par permanence, sur la base des fiches horaires renseignées mensuellement (exemple observé : plage de permanence de 8h à 20h et plage de garde de 20h à 8h, avec taux horaires distincts) ;
- Génération automatique d'une fiche de paie par agent, mentionnant l'entête de la clinique, la date, le nom et prénom, la situation matrimoniale, la catégorie, le téléphone, le numéro CNSS, le salaire de base, l'IRPP et la signature de l'employé ;
- Gestion des avances sur salaire et de la part patronale des cotisations sociales ;
- Gestion distincte de la rémunération des prestataires externes (médecins vacataires, réparateurs de climatisation et de groupe électrogène, agents d'entretien), avec factures normalisées pour les médecins.

9.10. Tableaux de bord et rapports

- Tableau de bord de suivi des stocks (niveaux, alertes, valorisation) ;
- Tableau de bord des achats et des dépenses par période et par fournisseur ;
- Rapport quotidien de caisse et d'inventaire ;
- Rapport mensuel de facturation des assurances par compagnie partenaire ;
- État récapitulatif mensuel de la paie et des heures de garde.

10. Besoins non fonctionnels

Catégorie	Besoin exprimé ou identifié
Ergonomie	Interface simple, accessible à des utilisateurs non spécialistes en informatique (comptables, personnel soignant)
Disponibilité	Fonctionnement quotidien sans interruption, y compris lors de l'inventaire matinal
Performance	Temps de réponse compatible avec un usage en continu à la pharmacie et à la caisse
Sécurité	Gestion des droits d'accès par profil (comptable, caisse, pharmacie, RH, direction)
Traçabilité	Historisation de tous les mouvements de stock, des validations et des modifications
Sauvegarde	Sauvegarde régulière et sécurisée des données (stock, comptabilité, paie)
Interopérabilité	Capacité d'interfaçage avec le logiciel de caisse et le logiciel d'assurance existants
Impression	Edition de documents normalisés (bons de commande, fiches de stock, factures, fiches de paie) — hors étiquettes produits, non requises à ce stade

11. Contraintes organisationnelles

- Effectif réduit dédié à la gestion administrative (deux comptables, un responsable RH), impliquant que le futur outil ne doit pas alourdir la charge de travail quotidienne ;
- Saisie manuelle historique des données, nécessitant une reprise soigneuse des données existantes (fournisseurs, produits, stocks initiaux, personnel) lors du déploiement ;
- Nécessité de maintenir la continuité de service pendant la période de transition, la clinique fonctionnant en continu (gardes de nuit, permanences) ;
- Validation hiérarchique systématique du Directeur Général pour les bons de commande, à préserver dans le processus digitalisé ;
- Coexistence, pendant la phase de transition, de l'outil actuel (Excel, cahiers) et du nouvel outil, nécessitant un accompagnement au changement adapté.

12. Contraintes techniques

- Absence d'infrastructure informatique centralisée connue à ce jour (postes de travail individuels de type ordinateur de bureau observés en comptabilité) ;

- Nécessité d'une interface équivalente avec le logiciel de gestion des assurances ;
- Prise en charge des moyens de paiement multiples déjà utilisés : espèces, virement bancaire, chèques, et paiements mobiles via passerelle (KKiaPay), avec deux comptes bancaires actifs identifiés (UBA, NSIA) ;
- Absence actuelle de solution d'étiquetage ou de codification (code-barres, QR code) des produits, à évaluer dans le cadre de la solution cible ;
- Nécessité de définir un hébergement (local ou cloud) garantissant la disponibilité, la sécurité et la sauvegarde des données de santé et financières de l'établissement.

13. Synthèse des besoins prioritaires

La synthèse ci-dessous présente une première priorisation des besoins recueillis, selon la méthode MoSCoW (Must have / Should have / Could have / Won't have), qui sera affinée et détaillée dans le Cahier des Charges Fonctionnel et Technique.

Priorité	Besoins concernés
Must have (indispensable)	Fiches de stock et de sortie digitalisées ; gestion des bons de commande et de livraison ; seuils d'alerte et suivi des péremptions ; inventaire quotidien automatisé ; intégration avec la caisse
Should have (important)	Calcul automatique de l'AIB et annexe fiscale ; gestion de la paie des médecins par garde et permanence ; tableaux de bord de suivi des stocks et des dépenses
Could have (souhaitable)	Codification et étiquetage des produits ; gestion avancée du circuit de retour patient ; historisation fine des consultations d'écran
Won't have – phase 1 (hors périmètre actuel)	Dossier patient informatisé ; module de consultation et d'hospitalisation ; portail patient ; application mobile ; business intelligence avancée

14. Conclusion et prochaines étapes

La séance de cadrage du 13 juillet 2026 a permis de dresser un diagnostic clair et partagé du fonctionnement actuel de la gestion des achats, des stocks et de la pharmacie de la Clinique BAGUIDI. Ce diagnostic met en évidence une organisation rigoureuse mais fragilisée par l'absence d'outils intégrés, exposant l'établissement à des risques évitables de rupture, de péremption et d'écart d'inventaire.

Les consultants Dr MASSENON Rhodes & Ing KOWI Afred Conseil recommande à la Direction Générale de valider les orientations présentées dans ce rapport, en particulier le périmètre de la première phase et les priorités fonctionnelles identifiées, afin d'engager sans délai la rédaction du Cahier des Charges Fonctionnel et Technique, préalable à la consultation des prestataires techniques et au démarrage du développement ou du paramétrage de la solution retenue.

Les prochaines étapes proposées sont les suivantes :

- Validation formelle du présent rapport par la Direction Générale ;
- Validation du Cahier des Charges Fonctionnel et Technique ;
- Implémentation de l’outil et Mise en place et Recettes
- Formation et Support technique

Le présent procès-verbal atteste que la réunion de cadrage du 13 juillet 2026 s'est déroulée dans les conditions décrites ci-dessus, et que les informations recueillies ont été validées par les parties présentes, dont les signatures figurent ci-dessous.

Pour la Clinique BAGUIDI

Dr BAGUIDI Rafiou
Directeur Général – Médecin du Travail
Clinique BAGUIDI « L'As du Cœur »

Signature

Pour les Consultants du Cabinet FAGUEZ SARL

Dr MASSENON Rhodes
Chef de mission

Signature

Ing. KOWI Alfred
Consultant Systèmes d'Information

Signature

Annexe

Liste des documents collectés et analysés

- Classeur Excel « Journal de Janvier 2026 » – onglets Achats, Ventes, Salaires, Caisse-Dépenses, Opérations Diverses, Prestations, Point AIB, Immobilisations ;
- Bon de livraison SoBAPS n° 26BLP0704 du 17 juin 2026 (pages 1 et 2) ;
- Fiche de suivi des heures de garde et de permanence médicale – mois de juin 2026 ;
- Notes manuscrites de cadrage rédigées en séance par les consultants (processus caisse-pharmacie, gestion des fournisseurs, gestion des assurances, gestion de la paie, architecture des journaux Excel).